

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Trauma de Davidson (DTS)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Trauma de Davidson
Sigla	DTS
Autores	Davidson, J. R., et al.
Año	1997
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Trauma y estrés postraumático
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Bobes et al., 2000)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No se localizo formulario español independiente con licencia explícita.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Trauma y estrés postraumático. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	3 subescalas de síntomas (Intrusión, Evitación/Embotamiento, Hiperactivación).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	17 ítems evaluados doblemente (frecuencia y severidad), total 34 respuestas.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos doble (0 a 4 para frecuencia y 0 a 4 para severidad).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 subescalas de síntomas (Intrusión, Evitación/Embotamiento, Hiperactivación).
Ítems	17 ítems evaluados doblemente (frecuencia y severidad), total 34 respuestas.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos doble (0 a 4 para frecuencia y 0 a 4 para severidad).
Relación ítem–dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria total de todas las frecuencias y severidades (0 a 136).

Regla de corrección	Sumatoria total de todas las frecuencias y severidades (0 a 136).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Un puntaje total > 40 se asocia con un diagnóstico clínico de TEPT.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Mide frecuencia y gravedad de síntomas de TEPT. Alta fiabilidad test-retest (.86) y consistencia interna (.99).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Mide frecuencia y gravedad de síntomas de TEPT. Alta fiabilidad test-retest (.86) y consistencia interna (.99).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Bobes et al., 2000)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Trauma y estrés postraumático en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Davidson, J. R., et al.; 1997.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Bobes et al., 2000)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Trauma y estrés postraumático
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 17 ítems evaluados doblemente (frecuencia y severidad), total 34 respuestas.; 3 subescalas de síntomas (Intrusión, Evitación/Embotamiento, Hiperactivación).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria total de todas las frecuencias y severidades (0 a 136).
Interpretación	Un puntaje total > 40 se asocia con un diagnóstico clínico de TEPT.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Davidson, J. R., et al. (1997). Escala de Trauma de Davidson.

Fuente de referencia del catálogo: Comercializado por MHS.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11891997/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3752042/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3752042/pdf/EJPT-4-21239.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	DTS española, 17 síntomas. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 e5965db271ac9f1f6c8fe05 941db31b2cb722eee9eb45c0549de86 871bcd8d4b.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	DTS española, 17 síntomas.
6. Periodo temporal	Última semana.
7. Escala/formato de respuesta	Cada síntoma se valora en frecuencia 0–4 y gravedad 0–4.
8. Algoritmo de puntuación	Para cada uno de 17 síntomas sumar frecuencia 0–4 y gravedad 0–4. Subtotales 0–68 y total 0–136. No adoptar un corte sin especificar la validación/población.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Validación chilena disponible en acceso abierto; no se trasladan parámetros a otras poblaciones sin justificación.
11. Baremos, cortes e interpretación	Un puntaje total > 40 se asocia con un diagnóstico clínico de TEPT. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Leiva-Bianchi y Gallardo (2013), validación chilena, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3752042/ . La escala estandarizada está sujeta a los derechos de su titular.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.